REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Anemias Hemolíticas

Doença falciforme, talassemias, membranopatias, enzimopatias e hemólises adquiridas em uma página

MAIS COBRADO

- **1º** Doença falciforme: **febre**, crises e profilaxia
- **2º** **Coombs direto** separa imune × não imune
- **3º** **Traço talassêmico** × anemia ferropriva
- **4º** **PTT/SHU**: esquizócitos + plaquetopenia

1 Reconhecer a hemólise

hemácia vive ~120 dias

Anemia + reticulocitose + LDH ↑ + bilirrubina indireta ↑ + haptoglobina ↓ = hemólise. Próximo passo: **Coombs direto** e **esfregaço**. IPR > 2 = medula respondendo.

	Intravascular	Extravascular
Onde	Dentro do vaso	Macrófagos do baço/fígado
Pistas	LDH muito ↑, haptoglobina indetectável, **hemoglobinúria**	Esplenomegalia, esferócitos
Exemplos	G6PD na crise, PTT/SHU, HPN, ABO, prótese	Esferocitose, AHAI quente, DF, talassemias

ESFERÓCITOS
Esferocitose ou AHAI quente

ESQUIZÓCITOS
MAT (PTT, SHU, CIVD), prótese

HEINZ / MORDIDAS
Deficiência de G6PD

2 Doença falciforme

Glu → Val na β-globina · autossômica recessiva

SS e **S/β⁰**: graves · **SC**: retinopatia e necrose óssea · **AS** (traço): não é doença. Teste do pezinho: **FS** = DF · **FAS** = traço · **FSC**. Confirmar por eletroforese/HPLC.

HbS polimeriza na hipóxia → **vaso-oclusão** (dor, STA, sequestro, AVC) + **hemólise** (anemia, litíase, priapismo, HP). **HbF protege** → sintomas após 6 meses. **Asplenia funcional** → germes encapsulados.

COMPLICAÇÕES AGUDAS

Quadro	Pista	Conduta
Febre	Risco de sepse pneumocócica	**Ceftriaxona** já, hemocultura
Crise dolorosa	Dor óssea/abdominal	Analgesia em **até 1 h** (opioide se intensa), sem hiper-hidratar
STA	**Infiltrado novo** + febre, dor torácica ou hipoxemia	Ceftriaxona + macrolídeo, O_2, espirometria, transfusão
Sequestro esplênico	Baço cresce + Hb cai ≥ 2 g/dL	Transfusão em pequenas alíquotas
Crise aplástica	**Reticulócitos baixos** · parvovírus B19	Transfusão
AVC	Déficit focal	**Exsanguineotransfusão** (HbS < 30%)
Priapismo	> 4 h	Emergência: urologia

Seguimento: penicilina dos **3 meses aos 5 anos** · vacinas do CRIE · ácido fólico · **Doppler transcraniano anual dos 2 aos 16 anos** (≥ 200 cm/s → transfusão crônica) · **hidroxiureia** ↑ HbF (PCDT: a partir de 2 anos) · TCTH é a cura.

3 Talassemias

microcitose por falta de cadeia de globina

β-menor: Hb normal ou pouco baixa, VCM muito baixo, hemácias normais/altas, **HbA2 > 3,5%**. **β-maior (Cooley):** sintomas aos 6–24 meses, fácies típica, dependente de transfusão + **quelação de ferro**.

α: 1 gene = silencioso · 2 = traço · 3 = **doença da HbH** · 4 = **Hb Bart → hidropsia fetal**.

4 Membrana, enzimas e adquiridas

ESFEROCITOSE
Anemia + icterícia + esplenomegalia + litíase precoce · **CHCM ↑**, **Coombs –**, teste **EMA** · esplenectomia após os 6 anos (vacinas antes).

G6PD
Ligada ao X · hemólise 24–72 h após **infecção, fava, primaquina, dapsona, sulfa, rasburicase** · dosagem pode ser normal na crise: repetir em 2–3 meses.

AHAI QUENTE × FRIA
Quente: **IgG**, esferócitos, LES/LLC → **prednisona 1 mg/kg**, rituximabe. Fria: **IgM/C3d**, Mycoplasma, EBV, linfoma → evitar frio, rituximabe.

HPN
Hemólise + **trombose atípica** (Budd-Chiari) + falência medular · citometria **CD55/CD59** · inibidor de C5 (vacina meningocócica antes).

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Toda febre na DF é emergência:** ceftriaxona sem esperar exames.
2. **Crise aplástica ≠ sequestro:** aplástica tem reticulócitos baixos; sequestro tem baço grande.
3. **Não transfunda** crise dolorosa não complicada.
4. **Hiper-hidratação** na crise dolorosa pode precipitar STA.
5. **STA começa como crise dolorosa:** reavalie o tórax todo dia.
6. **Teste de falcização não diferencia** traço de doença: use eletroforese/HPLC.
7. **Esferócitos em dois lugares:** Coombs – = esferocitose; Coombs + = AHAI.
8. **Microcitose com ferritina normal:** pense em talassemia, não dê ferro.
9. **HbA2** pode cair com ferropenia: corrija o ferro e repita.
10. **G6PD normal na crise** não exclui: repita depois.
11. **Rasburicase** é contraindicada na deficiência de G6PD.
12. **SHU típica:** antibiótico não é indicado.
13. **PTT:** troca plasmática sem esperar o ADAMTS13; evite plaquetas.
14. **CIVD** tem TP/TTPa alargados e fibrinogênio baixo; PTT/SHU têm coagulograma normal.

Contas e números

IPR = reticulócitos % × (Ht ÷ 45) ÷ fator de maturação (1; 1,5; 2; 2,5)
Mentzer = VCM ÷ hemácias: < 13 talassemia · > 13 ferropriva
ADAMTS13 < 10% = PTT · Transfusão crônica: **HbS < 30%**